

線上評估問卷 個案填寫表單 (2026-08-03 更新版)

本版為 2026-08-03 更新版 (原版: 06_第 4 場_線上評估問卷_個案填寫表單草案.md, 2026-07-18, 保留未動) 更新依據: 2026-08-03 台灣婦產科醫學會對議題 1-5 之回應 + 《藥局供應 ECP 評估與轉介流程表_更新版 20260803》用途: 供第 4 場專家會議檢視題目設計, 並作為資訊系統 (功能 B 問卷模組) 開發之文案底稿 體例: **粗體題目 + 選項** = 個案實際看到的文字 (力求淺顯); **【系統】** = 該題觸發之分流邏輯 (個案看不到);  = 經醫學會定案之項目;  = 仍待後續場次確認

本次變更摘要

題號	變更
首頁說明	新增「藥局供藥為就醫不及之替代方案」定位說明
3-3 驗孕	「我不願意驗孕」由  結束問卷改為  續填、可供藥 + 加掛四項告知
4-2 出血	維持  轉介、不產生條碼 (醫學會不採改  之建議)
6-4 體重	確定收集, 明確標示為「選填」; 未填不影響供藥
結果頁	新增  供藥 + 告知頁;  頁加註未就醫追蹤說明
附錄	新增嘔吐補服快速通道之個案端說明

填寫前說明（表單首頁文案）

這份問卷要做什麼？這是「緊急事後避孕藥」購藥前的線上評估。填完後，如果適合在藥局購買，系統會給你一個 QR Code（購藥條碼），帶著它和身分證件到試辦藥局，就可以由藥師評估後購買。全程約 3–5 分鐘。

請注意：

-  如果你來得及去看醫師，我們仍建議由婦產科醫師為你評估——藥局購買是為了讓「來不及就醫或不方便就醫」的人也能及時取得。
- 請本人填寫，購藥時也必須本人攜帶證件到藥局（不能請別人代買）。
- 事後避孕藥越早服用效果越好，請盡快完成。
- 你的填答內容受個人資料保護法保護，只用於本次購藥評估與衛教。
-  如果你現在有單側下腹劇烈疼痛、頭暈冒冷汗、臉色蒼白，請不要繼續填寫，立即就醫或撥打 119。

第一部分 | 基本資料與同意

題號	題目與選項	系統邏輯
1-1	姓名（將與到局證件核對）	【系統】存檔供 ⑤ 到局身分核對
1-2	出生年月日	【系統】自動計算年齡。未成年之供藥條件與家長同意，第 4 場（第 8 章）討論後補入年齡節點——本題先收集、分流規則暫缺 
1-3	身分證字號 / 居留證號（到局核對用）	【系統】供 ⑤ 核對「填答者 = 到場者 = 證件本人」
1-4	手機號碼（接收 QR Code 與通知）	【系統】發送條碼；另供未就醫追蹤聯繫使用（見結果

題號	題目與選項	系統邏輯
		頁)
1-5	☐ 我已閱讀並同意《個人資料提供同意書》（連結全文；必勾）	【系統】未勾不可續填； 5-2 之線上簽署要件
1-6	☐ 我確認本問卷由我本人填寫，且知道購藥須本人親自到藥局（必勾）	【系統】未勾不可續填；對應「不可代購」

第二部分 | 用藥安全（對應流程表 ① 禁忌檢核）

題號	題目與選項	系統邏輯
2-1	你是否曾經對「事後避孕藥」或其成分 Levonorgestrel (LNG) 過敏？ ☐ 是 ☐ 否	【系統】「是」→ ● 結束問卷、顯示就醫指引（本試辦僅 LNG、無替代品項）、不產生條碼
2-2	醫師是否告訴過你，你目前有「嚴重肝病」？（指肝硬化、肝衰竭、黃疸、腹水） ☐ 是 ☐ 否說明：B 型肝炎帶原、脂肪肝、輕度肝指數異常都不算，請放心選「否」。	【系統】「是」→ ● 結束問卷、顯示就醫指引、不產生條碼

✓ 設計註〔議題 1・醫學會已定案〕：血栓病史、子宮外孕病史、骨盆腔發炎（PID）均非禁忌，線上不設篩選題、不擋藥（勿誤擋）。惟此三類病史需於到局時由藥師關懷詢問並加掛對應衛教（血栓：用藥須較小心之提醒；子宮外孕病史：務必回診追蹤；PID：雙重避孕與性病防治衛教）。

是否於線上加設「非分流用」之病史預填題以縮短現場時間，建議第 4 場一併確認——若加設，題目須明確標示「這幾題不會影響你能不能購買，只用來提供更合適的用藥提醒」，避免民眾誤以為勾選即遭拒。●

第三部分 | 懷孕可能性（對應流程表 ②，日本核對表 + 3 週驗孕判斷）✔〔議題 2・醫學會已定案〕

題號	題目與選項	系統邏輯
3-1	下列情況，你符合哪些？ （可複選） ☐ 我的月經週期不規則 ☐ 上次月經到現在，已經超過平常的週期天數還沒來 ☐ 上次月經的量特別少或天數特別短，我不確定那是不是月經 ☐ 我最近生產或流產，月經還沒恢復 ☐ 以上都沒有	【系統】「以上都沒有」→ 跳第四部分（不需驗孕）； 勾任一項 → 續 3-2
3-2	距離今天「3 週（21 天）以前」，你是否曾發生沒有避孕（或避孕失敗）的性行為？ ☐ 否（只有最近 3 週內才發生沒有避孕或避孕失敗的性行為） ☐ 是	【系統】「否」→ 不需驗孕、續填（系統於衛教單追加「不排除本次之前已懷孕之可能」說明）；「是」→ 續 3-3
3-3	建議你先用驗孕棒驗孕，並回報結果： ☐ 陰性（一條線） ☐ 陽性（兩條線） ☐ 還沒驗——我會買驗孕棒，驗完回來這裡填結果 ☐ 還沒驗——我會到藥局買驗孕	【系統】「陰性」→ 續填。「陽性」→ ● 結束問卷、轉介婦產科（已確定懷孕不應服用本藥；並確認懷孕位置、排除子宮外孕）、不產生條碼。✔「我不想

題號	題目與選項	系統邏輯
	棒，結果直接告訴藥師□ 我不想驗孕✔ 說明：選「我不想驗孕」仍然可以購買，藥師會提供你需要注意的事項。	驗孕」→ ● 續填、可產生條碼；系統加掛「不願驗孕告知四項」至個人化衛教清單，並納入未就醫追蹤名單。「驗完回來填」→ 問卷暫存+發送續填連結，提醒盡快（時效以實際性行為時間計算、不因暫存延長）；回填後依陰性/陽性分流。「到藥局告訴藥師」→ 續填後續題目，通過者產生附「待驗孕」註記之條碼；到局由藥師確認結果——陰性→照常供藥、陽性→現場轉介婦產科（不供藥）。

✔ 3-3 附加：選「我不想驗孕」者之告知文案（供藥時由藥師逐項確認）

依 2026-08-03 醫學會定案：不因不願驗孕而擋藥，改以充分告知處理。

1. 如果你已經確定懷孕，就不應該服用這個藥——它對已經成立的懷孕沒有效果，也不能終止懷孕。
2. 如果懷疑自己可能已經懷孕，一定要注意後續追蹤。有可能是這次之前就已經懷孕而你不知道（例如幾天前曾有不安全的性行為、沒有全程使用保險套），這次吃藥其實已經來不及、沒有效果。
3. 月經沒有按照預計時間來，或是出現亂經，要去找醫師。
4. 服藥後大約 3 週建議驗孕，或回診確認避孕成功。

第四部分 | 月經與出血狀況（對應流程表 ③ 兩問法）〔議題 3・醫學會已定案〕

題號	題目與選項	系統邏輯
4-1	你最後一次月經是什麼時候開始的？（日期選擇；記不得可選「大約」）	【系統】存檔供藥師參考
4-2	那一次月經和你平常的月經比起來： ☐ 和平常一樣 ☐ 量、天數或顏色和平常不一樣 ☐ 不清楚 ☐ 我現在正在出血，不確定是不是月經	【系統】「和平常一樣」→ 續第五部分；其餘 →  維持轉介婦產科查出血原因、不產生條碼。  醫學會確認不改為「先給藥 + 當日轉介」，理由為異常出血中有部分情形服藥後會出問題。  結果頁須納入未就醫追蹤名單。
4-3	你現在是否有：單側下腹劇烈疼痛、頭暈冒冷汗、或臉色蒼白？ ☐ 有 ☐ 沒有	【系統】「有」→  急症警示頁：請立即就醫 / 急診（疑似子宮外孕急性徵象）

第五部分 | 時間計算（對應流程表 ④ 時效窗口）

題號	題目與選項	系統邏輯
5-1	最近一次沒有避孕（或避孕失敗，例如保險套破掉、滑脫）的性行為，是什麼時候？（日期 + 大約時間）	【系統】自動計算距今時數： ・ ≤ 72 小時 → 通過（到局後以當下時間重算） ・ 72–96 小時 →  就醫指引、不產生條碼（已定案・非議題） ・ > 96 小時

題號	題目與選項	系統邏輯
		→ ● 就醫指引：告知可請醫師評估 UPA（120 小時內） / 含銅子宮內避孕器（5 日內） + 剩餘時數急迫性

第六部分 | 給藥準備預填（供藥師預先帶出個人化衛教；不影響是否供藥）

設計註：以下對應流程表 ⑥ 之 ● 情境。本部分全部題目均為選填，且不影響能否購買——表單須於本部分開頭明確標示此點。敏感情境（疑似性暴力 / 性侵害、社會風險）不設線上題，一律由藥師現場關懷詢問。

本部分開頭文案（個案可見）：

以下問題都可以不填，也不會影響你能不能購買。填了可以讓藥師提供更適合你的用藥提醒。

題號	題目與選項	系統邏輯
6-1	你目前正在哺乳嗎？ ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不想填	【系統】「是」→ 預帶哺乳衛教（⑥-4；可繼續哺乳、服藥前先哺乳）
6-2	你目前有固定服用的藥物或保健食品嗎？（可複選） ☐ 抗癲癇藥物 ☐ 聖約翰草（St. John's Wort） ☐ 其他：_____ ☐ 沒有 ☐ 不想填	【系統】勾抗癲癇藥 / 聖約翰草 → 預帶交互作用衛教（⑥-5；效果可能降低）；到局後藥師得於同意 + 健保卡下查雲端藥歷核對
6-3	最近一個月內，你是否已經	【系統】「是」→ 預帶常

題號	題目與選項	系統邏輯
6-4 	用過事後避孕藥？ ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不想填 (選填) 你的體重與身高： _____kg / _____cm ☐ 不想填 填說明：這題可以不填，不影響購買。填寫是因為體重較重時，這個藥的效果可能會下降，藥師可以提醒你。	規避孕強化衛教 + 追蹤說明 (6-3) 【系統】有填且 >70kg 或 BMI>26 → 預帶「效果可能降低」告知 (6-7)。 〔議題 4・醫學會已定案〕確定收集，但為選填；未填不得影響供藥。收集之資料可供後續追蹤分析。

送出後：結果頁文案（更新版）

通過（產生 QR Code）

你可以到試辦藥局購買了。這是你的購藥條碼（QR Code），有效期至（系統帶入：距性行為滿 72 小時之時點）。請本人攜帶「①這個條碼 + ②身分證件」到下列試辦藥局（系統帶入附近藥局清單 + 營業時間）。到藥局後，藥師會再次確認幾個問題並提供衛教，完成後即可購買。⚠️ 越早服用效果越好，請盡快前往。

通過，但有需要特別注意的事 (新增頁；3-3 選「我不想驗孕」者)

你可以到試辦藥局購買，但有幾件事請務必記得。（條碼與前往方式同上）藥師會與你說明以下事項，請特別留意：

- 如果你已經確定懷孕，就不應該服用這個藥。
- 如果懷疑可能已經懷孕，**一定要注意後續追蹤**——有可能是這次之前就已經懷孕（例如沒有全程使用保險套），這次吃藥來不及。
- 月經沒有按預計時間來，或出現亂經，要去找醫師。
- 服藥後大約 3 週建議驗孕，或回診確認避孕成功。（系統：納入未就醫追蹤名單）

● 建議就醫（未通過任一關卡）

依你的填答，建議直接就醫，由醫師為你評估。原因：（系統帶入命中關卡之白話說明）（逾 96 小時者追加：）醫師仍可評估其他方式：**UPA 事後避孕藥（120 小時內）**或**含銅子宮內避孕器（5 日內）**——你還剩約（系統帶入）小時，請盡快就醫。（附：附近婦產科清單 / 夜間急診資訊；就醫會經歷什麼之簡要說明）

✅（系統）納入未就醫追蹤名單——依醫學會建議，本試辦無強制就醫之權力，須記錄並追蹤經建議轉介卻未就醫者之後續情況，累積資料供未來政策參考。追蹤方式與同意取得方式待第 5 場（第 12、13 章）確認。●

⚠ 急症警示（4-3 答「有」）

你的症狀需要立即就醫。單側下腹劇痛、冒冷汗、臉色蒼白可能是子宮外孕等急症的警訊，請立刻前往急診或撥打 119，不要等待。

附錄一 | 到局現場流程（個案不填寫，列出供對照）

到藥局後由藥師執行，個案口頭回答即可：

1. 身分核對 (❶)：掃描 QR Code，核對到場者 = 線上填答者 = 證件本人；不符 → ☐ 不供藥、告知現行就醫途徑。
2. 時效與出血重算 (❷-3)：以到場當下重新計算時數、確認是否新增出血；條碼附「待驗孕」註記者，藥師先確認驗孕結果（陰性 → 續流程；陽性 → 現場轉介婦產科、不供藥）。
3. 醫療 / 社政銜接檢核 (❸)：藥師現場詢問（含線上未預填之敏感情境——疑似性暴力 / 性侵害、社會風險，以及血栓 / 子宮外孕病史 / PID），依結果供藥 + 加掛對應加值衛教、轉介或通報。
4. 衛教逐項確認 (八)：藥師依系統帶出之個人化衛教清單逐項確認，完成後交付藥品、結案。

✅ 附錄二 | 嘔吐補服快速通道（個案端說明文案，新增）

依 2026-08-03 醫學會定案，補服須設時間限定、須再收費，並併同提供就醫之選擇。

衛教單與結果頁應載明之文案：

如果吃藥後 2-3 小時內吐了，藥效可能沒有被吸收，需要補吃一顆。 - 請在 24 小時內帶著原本的購藥條碼回到藥局，藥師確認後可以幫你補一顆（需要再付一次藥費）。 - 你也可以選擇去看婦產科：如果吐是這個藥引起的，再吃一顆可能會吐得更厲害；醫師可以一併處理嘔吐的問題，也可以和你討論其他的避孕方式。

系統規則：結案後 24 小時內憑原條碼，藥師以「補服代碼」記錄、免重新評估、不計入短期重複使用、跨店適用。

表單題目 ↔ 流程表對照（審閱用）

表單	流程表	本版狀態
首頁說明	○ 制度定位	✅ 新增「來得及就醫者仍建議就醫」
第一部分 1-1~1-6	⑤ 前置確認之線上前置	1-2 年齡節點待第 8 章決議 ●
第二部分 2-1、2-2	① 禁忌檢核 #1、#2	✅ 議題 1 定案：三類病史不設分流題；是否加設非分流預填題待確認 ●
第三部分 3-1~3-3	② 懷孕可能性 ①②③	✅ 議題 2 定案：不願驗孕改 ● 供藥 + 四項告知
第四部分 4-1~4-3	③ 兩問法 + 急性徵象	✅ 議題 3 定案：維持 ●
第五部分 5-1	④ 時效窗口	72-96h 不給藥已定案（非議題）

表單	流程表	本版狀態
第六部分 6-1～6-4	⑥-3/4/5/7	✅ 議題 4 定案：6-4 體重確定收集但選填
結果頁 ✅ / 🟡 / 🔴 / ⚠️	通過 / 🟡 供藥 + 告知 / 🔴 就醫指引 / ③ 急性徵象	✅ 新增 🟡 頁；🔴 頁加未就醫追蹤
附錄二	八-2、8-1 嘔吐補服	✅ 議題 5 定案：24h + 自費 + 併同提供就醫選擇

※ 內部生產步驟：定稿後所有個案可見文字送印 / 上線前，先經**民眾閱讀測試**（與衛教素材同一原則）。